



**CLINICAL PATHWAY
DIABETES MELLITUS
RSU ANWAR MEDIKA**

No. RM:.....

Nama Pasien		BB	Kg
Jenis Kelamin		TB	Cm
Tgl lahir	Tgl. Masuk		Jam.....
Diagnosa Masuk RS	Tgl. Keluar		Jam.....
Penyakit Utama	Kode ICD: Lama rawat		Hari
Penyakit Penyerta	Kode ICD: Rencana rawat		
Komplikasi	Kode ICD R.Rawat/Kelas		/.....
Tindakan	Kode ICD: Rujukan		Ya/ Tidak
Dietary Counseling and Surveillance	Kode ICD: Z71.3		

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI RAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. ASSESMEN AWAL									
a. ASSESMEN AWAL MEDIS	Dokter IGD	**							Pasien masuk dari IGD
	Dokter Spesialis	**							Pasien masuk dari Poliklinik Penyakit Dalam
b. ASSESMEN AWAL KEPERAWATAN	Perawat Primer: Kondisi umum, tingkat kesadaran, TTV, riwayat alergi, skrining gizi, nyeri, status fungsional: brtel index, risiko jatuh, kebutuhan edukasi dan budaya	**							Dilanjutkan dengan assessmen bio, psiko-sosial-spiritual dan budaya
2. LABORATORIUM	GDS/ GDP	**							
	DL, SE, RFT	**							
	UL, LFT, Albumin, Kolesterol, TG	*							
									Varian
3. RADIOLOGI/IMAGING	Foto Polos Thorax AP	**							
		**							Varian
4. KONSULTASI	Spesialis Penyakit Dalam	**							
5. ASSESMEN LANJUTAN									
a. ASSESMEN MEDIS	Dokter DPJP	**	**	**					Visite harian/follow up
	Dokter non DPJP/dr.Ruangan	*	*	*					Atas indikasi/emergency
b. ASSESMEN KEPERAWATAN	Perawat penanggung jawab	**	**	**					Dilakukan dalam 3 shift
c. ASSESMEN GIZI	Tenaga gizi (nutrisionis/ dietisen)	**	**	**					Lihat risiko malnutrisi melalui skrining gizi dan mengkaji data antropometri, biokimia, fisik/klinis, riwayat makan termasuk alergi makanan serta riwayat personal. Assessmen dilakukan dalam waktu 48 jam.
d. ASSESMEN FARMASI	Telaah resep	**	**	**					
	Rekonsiliasi obat	**	**	**					Dilanjutkan dengan intervensi yang sesuai telaah dan rekonsiliasi obat.
6. DIAGNOSIS									
a. DIAGNOSIS MEDIS	Diabetes Mellitus								
b. DIAGNOSIS KEPERAWATAN	a. Kode : D.0027 (Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah;Hiperglikemi dan Hipoglikemi)	*							Masalah keperawatan yang dijumpai setiap hari. Dibuat oleh perawat penanggung jawab.
	b. Kode : D.0076 (Nausea)								Mengacu pada SDKI
	c. Kode : D.0077 (Nyeri Akut)	*							
c. DIAGNOSIS GIZI	NI-2.1 Asupan oral tidak adekuat dihubungkan dengan penurunan nafsu makan ditandai dengan asupan kurang dari kebutuhan.	**							Sesuai dengan data assessmen, kemungkinan saja ada diagnosis berubah selama perawatan.
	NI-5.4 Penurunan kebutuhan zat gizi (KH) dihubungkan dengan gangguan fungsi endokrin ditandai dengan kadar glukosa darah tinggi.	**							
	NI-5.8.4 Tidak konsisten dalam mengkonsumsi karbohidrat dihubungkan dengan kurangnya motivasi untuk merubah pola makan sesuai anjuran diit ditandai dengan peningkatan kadar HbA1C.	**							

	a. Identifikasikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri	**								
	b. Ajarkan teknik nonfarmakoogis untuk mengurangi rasa nyeri	**								
	c. Kolaborasi pemberian analgetik, <i>jika perlu</i>									
c. TLI GIZI	1. Energi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, aktifitas fisik dan stress. Kebutuhan kalori basal yaitu 25-30 kkal/kg BBI/hari 2. Protein cukup, yaitu 10-15% kebutuhan energy total 3. Asupan lemak dianjurkan sebesar 20-25% kebutuhan total energi dan tidak dianjurkan melebihi 30% total energi 4. Karbohidrat sebesar 45-65% dari kebutuhan total energi. Konsumsi karbohidrat <130 gr/hari tidak dianjurkan 5. Serat cukup, yaitu 20-25 gr/hari dengan mengutamakan serat larut air 6. Natrium sama seperti orang sehat yaitu <3000 mg/hari dan disesuaikan jika disertai hipertensi 7. Cukup vitamin dan mineral sesuai kebutuhan 8. Pemanis alternatif dapat digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman	**								Bentuk makanan, kebutuhan zat gizi disesuaikan dengan usia dan kondisi klinis
d. TLI FARMASI	Rekomendasi kepada DPJP	*								Sesuai dengan hasil monitoring
11. MONITORING & EVALUASI (Monitor Perkembangan Pasien)										
a. DOKTER DPJP	Assessmen ulang & review verifikasi rencana asuhan	**	**	**						
b. KEPERAWATAN	a. Monitor kadar gula darah	**	**	**						Mengacu pada SLKI
	b. Monitor mual	**	**	**						
	c. Monitor asupan nutrisi dan kalori	**	**	**						
	d. Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemerian analgesik	**	**	**						
	e. Monitor efektifits analgesik	**	**	**						
c. GIZI	Status Gizi berdasarkan antropometri	**	**	**						Sesuai dengan masalah gizi dan tanda gejala yang akan dilihat kemajuannya. Mengcu pada IDNT (Interntional Dietetics & Nutrition Terminology)
	Hasil biokimia terkait gizi	**	**	**						
	Fisik klinis terkait gizi	**	**	**						
	Asupan makan	**	**	**						
	Penerapan dan kepatuhan terhadap anjuran diit	**	**	**						
d. FARMASI	Monitoring interaksi obat	**	**	**						Menyusun software interaksi. Dilanjutkan dengan intervensi farmasi yang sesuai hasil monitoring
	Monitoring efek samping obat	**	**	**						
	Pemantauan terapi obat	**	**	**						
12. MOBILISASI/ REHABILITASI										
a. MEDIS		*	*	*						Tahapan mobilisasi sesuai kondisi pasien
b. KEPERAWATAN		*	*	*						
c. FISIOTERAPI		*	*	*						
13. OUTCOME/ HASIL										
a. MEDIS	Kadar gula darah menurun		**	**						
	Keluhan subyektif berkurang/tidak ada	**	**	**						
b. KEPERAWATAN	Kestabilan Kadar Glukosa Darah (L.03022)			**						Mengacu pada SLKI Dilakukan dalam 3 shift
	a. Kadar gula darah membaik			**						
	b. Kesadaran meningkat			**						
	c. Pusing menurun			**						
	Tingkat Nausea (L.08065)			**						
	d. Nafsu makan meningkat			**						
	e. Keluhan mual menurun			**						
	Tingkat Nyeri (L.08066)			**						
	f. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat			**						
	g. Keluhan nyeri menurun			**						
h. Frekuensi nadi membaik			**							
c. GIZI	Asupan makan ≥ 80% dari kebutuhan			**						Status gizi optimal
	Status gizi normal berdasarkan antropometri			**						
	Nilai laboratorium normal			**						
	Pengetahuan dan kepatuhan anjuran diit meningkat			**						
d. FARMASI	Terapi obat sesuai indikasi			**						Meningkatkan kualitas hidup pasien
	Obat rasional			**						
14. KRITERIA PULANG	Tanda vital normal			**						Status pasien/ tanda vital sesuai dengan PPK
	Kadar gula darah menurun			**						
	Keluhan subyektif berkurang/tidak ada			**						

15.	RENCANA PULANG/ EDUKASI PELAYANAN LANJUTAN	Resume medis dan keperawatan			**					Pasien membawa resum perawatan/ surat rujukan/ surat kontrol/ homecare saat pulang
		Penjelasan diberikan sesuai dengan keadaan umum pasien			**					
		Surat pengantar kontrol			**					
		VARIAN								

...../...../.....

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

Perawat Penanggung Jawab

Pelaksana Verifikasi

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan:

**	Yang harus dilakukan
*	Bisa atau tidak
√	Sudah dilakukan